

Un niño autista en su clínica

Para médicos de familia, enfermeros y profesionales de la salud — cuidar a un niño preescolar autista (aproximadamente de 2 a 5 años).

la idea principal

El autismo, a través del **monotropismo**, significa que la atención de un niño se concentra en unos pocos «túneles» profundos e intensos a la vez. Dentro de un túnel, la focalización es vívida y rica; fuera de él, las cosas apenas se registran, incluyendo a veces la dolor, el hambre o que alguien hable. Cambiar de túnel cuesta una energía real (*inercia autística*). Esto explica los intereses fuertes, las reacciones sensoriales, la necesidad de rutina y los colapsos (*meltdowns*)/bloqueos (*shutdowns*). Lo más útil que puede hacer en una clínica es trabajar **con** el túnel, no contra él.

Lo que puede observar — y lo que realmente está sucediendo

Puede observar...	Lo que suele suceder
No hace contacto visual; mira hacia otro lado; parece ignorarle	El contacto visual y la atención dividida cuestan recursos escasos; mirar hacia otro lado ayuda al niño a regularse y escuchar
Profundamente absorto en un objeto; alinea cosas; juega «diferente»	Juego monotrópico : válido y significativo, no es «incorrecto»; a menudo es la ruta del niño hacia la calma y el aprendizaje
Llanto súbito, gritos, se queda flácido o en silencio	Un colapso (<i>meltdown</i>) o bloqueo (<i>shutdown</i>) involuntario por luces, ruido, la espera o el dolor; <i>no</i> es mala conducta
No dice dónde le duele; ignora un golpe o algo caliente	Cuando está absorto, la dolor y las señales internas pueden realmente no registrarse
Lento al responder; repite sus palabras	Tiempo de procesamiento + comunicación literal y de canal único

Intente esto

- **Lea primero a la familia.** Ofrezca un breve formulario previo a la visita (la herramienta AASPIRE *Autism Healthcare Accommodations Tool*, autismandhealth.org) preguntando sobre necesidades sensoriales, de comunicación y procedimentales, y léalo antes de que lleguen.
- **Reserve el horario más tranquilo** (el primero o el último), permita la presencia de un adulto de confianza y acepte su **kit sensorial** (auriculares canceladores de ruido, gafas de sol, un objeto de confort o interés).
- **Reduzca la carga**: atenúe las luces, silencie los pitidos donde sea posible, evite perfumes fuertes.
- **Diga qué va a pasar, y luego hágalo** — frases cortas y literales, un paso a la vez; muestre el equipo primero.
- **Permita que el niño mire hacia otro lado, haga stimming y sostenga su objeto de interés** durante el examen. Únase a su interés para crear rapport *antes* de examinarlo.

Evite esto

- Forzar el contacto visual, sujetar al niño físicamente o presentar un procedimiento por sorpresa.
- Instrucciones verbales largas o frases como «¡sé valiente!» — diga exactamente lo que va a pasar, y cúmplalo.
- Interpretar unos minutos de calma y masking como que «está bien» — un preescolar puede pagar la visita con un bloqueo posterior.

Cuándo buscar más apoyo

Derive temprano para una evaluación del autismo si nota una atención lenta o «pegajosa», intereses focalizados intensos, diferencias sensoriales o juego atípico; la identificación temprana ayuda a las familias a adaptar el entorno, no al niño. Observe el **burnout autístico / «regresión»** bajo sobrecarga: una pérdida de habilidades suele significar *reducir las demandas y restaurar el descanso y los intereses*, no presionar más. Tome siempre en serio la **preocupación parental**. Oriente hacia la enfermera escolar, los servicios pediátricos y el apoyo para padres dirigido por autistas.

Si el niño es una niña

Las niñas suelen ser mejores en el **camuflaje** temprano y se pasan por alto más a menudo. Tome en serio la preocupación parental incluso cuando la presentación parezca «sutil» o «sociable» — el esfuerzo del masking en la clínica es un esfuerzo real.

Acerca de esta guía

Asistida por IA, derivada de los borradores de investigación del proyecto — la brève sobre el **Monotropismo** y el **Guide pour les praticiens et les soins de santé** (Parties 3.1 & 4). Utiliza el lenguaje de identidad primero («niño autista»). **Informativo — no es un consejo médico ni una herramienta de diagnóstico.** El monotropismo es una teoría poderosa pero aún en desarrollo; adapte siempre al niño individual.

Fuentes clave. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2018/2023); Dwyer (2025); AASPIRE Healthcare Toolkit / AHAT (autismandhealth.org); Raymaker et al. (2020, autistic burnout); Kelly Mahler (2024, interoception); Landry & Bryson (2004, sticky gaze). Las citas completas están en los borradores fuente.